

REDiseno del proceso - de ocho sub-procesos a cuatro estados

PROCESO ACTUAL - ocho sub-procesos	ACCION DE REDISENO	PROCESO REDISENADO
S1 · Recepcion y normalizacion de la solicitud Formulario libre que acepta cualquier cosa	ELIMINAR	La solicitud nace estructurada en N1: el medico elige del catalogo, no escribe texto libre. No hay nada que normalizar
S2 · Extraccion de datos del PDF 4 min de transcripcion manual · 21% del esfuerzo	**REDUCIR ALCANCE**	E1 · EXTRACCION sobrevive solo para documentos clinicos. Los campos administrativos ya vienen capturados desde N1
S3 · Verificacion de sustento completo Se descubre a las 24 h · 23% observaciones	**ELIMINAR EL ESTADO**	"Observacion" deja de ser un estado del expediente y pasa a ser una condicion de envio . No hay carta de observacion
S4 · Vigencia, plan, deuda, acumulado 3 min en dos pantallas	UNIFICAR	E2 · ADJUDICACION UNIFICADA DE POLIZA Una sola evaluacion devuelve elegibilidad + carencia + cobertura + exclusion + copago, con la cita textual de la version vigente. Estaban separados porque eran tres pantallas y tres personas , no porque sean tres decisiones.
S5 · Carencia y preexistencia 2 min de aritmetica manual	UNIFICAR	
S6 · Cobertura, exclusion y copago 7 min buscando en el manual · 37% del esfuerzo	UNIFICAR	
S7 · Casos limite Derivacion defensiva: 55% no requería criterio clinico	REDISTRIBUIR	E3 · RUTEO MEDIDO lo hace el sistema por umbral, no el analista por miedo. El auditor deja de ser valvula de escape
S8 · Emision de la carta Copiado a mano desde tres pantallas	ABSORBER	En el carril automatico decidir y emitir son el mismo acto . E4 solo es un estado cuando hay firma humana que esperar

LOS PASOS QUE NO EXISTIAN - un rediseño que solo quita pasos es un recorte, no un rediseño

N1 RESPUESTA DE COBERTURA EN EL PUNTO DE LA ORDEN Responde antes de que exista la solicitud, con cita y copago estimado. Lo habilita: que responder cueste centimos y no 7 minutos.	N2 AUTORIZACION POR EPISODIO El esquema oncologico o el plan de terapias, autorizado una vez. Lo habilita: que revalidar la elegibilidad sea gratis.	N3 ESTIMACION DE COSTO AL AFILIADO El copago de bolsillo, antes del procedimiento. Lo habilita: el motor determinista ya calcula el numero.	N4 CURADURIA DE LA POLITICA como proceso continuo Rol nuevo. Cada endoso se publica con version, vigencia y diff. Sin el, no se sostienen R2 ni F4.	N5 EXENCION POR DESEMPEÑO del prestador (gold-carding) Ataca el volumen de entrada, no su costo unitario. Decision del sponsor. El sistema produce el dato; no toma la decision.
---	--	---	---	---

LO QUE SE EVALUO Y SE MANTIENE

Fusionar el guardrail dentro de E1 -> **NO**. Debe correr antes de que el contenido toque un modelo.

Fusionar el ruteo (E3) con la adjudicacion (E2) -> **NO**. Consumen insumos distintos.

Que el agente absorba el ruteo -> **NO**. Volveria a poner lo no determinista en la decision (veto V1).

Eliminar el control humano en casos limite -> **NUNCA**. Es el invariante R3.

Reducir las 8 capas de guardrail -> **NO**. El orden barato->caro ya las hace baratas.

El HITL es el unico paso que se conserva por razones que no son de eficiencia.

EFEECTO SOBRE EL PROCESO

Sub-procesos / estados de negocio	8	4
Toques humanos por solicitud	1.23	0.40
Solicitudes que entran a la mesa	7,800/mes	~6,400/mes
El prestador conoce la respuesta	2 a 7 dias	en el acto

AUTOR: Jonatan Sanchez - DataPath | AI Solutions Architect

LEYENDA / NOTAS

- El paso desaparece del proceso
- El paso se unifica o se absorbe en otro
- El paso se reduce o cambia de dueño
- Capacidad que hoy no existe

Orden del analisis: ELIMINAR -> UNIFICAR -> REORDENAR -> AUTOMATIZAR.
 Automatizar primero congela el desperdicio.

Lo que rediseña el proceso no es la IA: es que el costo marginal de una decision caiga de 19 minutos a segundos. La IA es lo que hace que caiga. Analisis completo en 04a_rediseño_del_proceso.md

PROYECTO

Mesa de preautorizacion medica - Vitalia Salud EPS

DIAGRAMA

Rediseño del proceso (ESIA)

NIVEL

Logico - proceso

CODIGO
D-10

VERSION
1.3

FECHA
2026-09-05